

PAUSE CARDIO

Nouveautés de la semaine du 5 septembre 2026

35 nouveautés cette semaine, dont 11 susceptibles de changer votre pratique.

INSUFFISANCE CARDIAQUE **Changement de pratique** Essai randomisé · TRIC-I-HF

Tricuspid-Valve Intervention in Heart Failure.

NEJM · 30 août 2026 · 360 patients, 29 centres allemands, essai ouvert 2:1 · ESC 2026

Chez 360 patients âgés (80 ans en moyenne) avec insuffisance tricuspide sévère symptomatique et risque élevé d'événements d'insuffisance cardiaque, la réparation percutanée ajoutée au traitement médical fait mieux que le traitement médical seul sur un critère hiérarchique décès, hospitalisation pour IC et qualité de vie à un an, et réduit de 60 % le risque de décès ou d'hospitalisation pour IC à trois ans. C'est le premier essai randomisé qui démontre un bénéfice sur les événements durs.

En pratique : l'insuffisance tricuspide sévère symptomatique n'est plus une indication de confort. Un patient âgé avec IT sévère, hospitalisation récente pour IC, congestion rénale ou hépatique malgré un traitement optimisé, mérite désormais d'être adressé tôt à une équipe valvulaire pour discuter une réparation bord à bord, avant que la défaillance droite ne rende le geste vain.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)INSUFFISANCE CARDIAQUE **Changement de pratique** Méta-analyse · ABYSS + SMART-DECISION

Discontinuation of β -blockers in stable patients with previous myocardial infarction, preserved left ventricular ejection fraction, and no heart failure: a pooled analysis of individual patient data.

Lancet · 30 août 2026 · 6 238 patients, données individuelles de deux essais randomisés

Analyse groupée des données individuelles d'ABYSS et de SMART-DECISION chez 6 238 patients stables plus de six mois après un infarctus, avec FEVG ≥ 40 % et sans insuffisance cardiaque. L'arrêt du bêtabloquant satisfait aux critères de non-infériorité sur le critère principal (décès, infarctus, AVC ou hospitalisation cardiovasculaire) comme sur le critère secondaire clé (décès, infarctus ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque), quelle que soit la FEVG de départ.

En pratique : chez un coronarien stable à plus de six mois de son infarctus, FEVG ≥ 40 %, sans insuffisance cardiaque ni autre indication, l'arrêt du bêtabloquant peut se discuter en consultation sans crainte d'un excès de décès, d'infarctus ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Rester attentif au risque d'hospitalisation cardiovasculaire, légèrement plus fréquente après arrêt dans ABYSS, et vérifier l'absence d'angor, d'arythmie ou d'hypertension qui justifieraient de le garder.

[Article original](#)

Timing of PCI in Patients Undergoing Transcatheter Aortic-Valve Implantation.

NEJM · 30 août 2026 · 986 patients, 48 centres européens, essai ouvert de non-infériorité · ESC 2026

Chez des patients porteurs d'un rétrécissement aortique serré et d'une maladie coronaire, faire le TAVI d'abord puis l'angioplastie s'est révélé non inférieur à la séquence habituelle angioplastie puis TAVI : critère composite à un an chez **22,2 %** contre **24,2 %**. L'ordre des gestes peut donc se décider au cas par cas, et traiter la valve en premier a parfois rendu l'angioplastie moins urgente, voire inutile.

En pratique : devant un rétrécissement aortique serré avec lésions coronaires, il n'est plus obligatoire de « faire les coronaires d'abord ». Traiter la valve en premier est une option sûre, qui évite la bithérapie antiplaquettaire au moment du TAVI, semble saigner moins et permet de réévaluer à froid la nécessité de l'angioplastie. La séquence se discute en équipe selon l'anatomie et les symptômes du patient.

[Article original](#)

Prasugrel versus Ticagrelor in Acute Coronary Syndromes.

NEJM · 29 août 2026 · 17 095 patients, Suède, essai randomisé en grappes sur registre · ESC 2026

Sept régions suédoises ont basculé, dans un ordre tiré au sort, du ticagrelor au prasugrel comme inhibiteur P2Y12 par défaut après angioplastie pour syndrome coronarien aigu. À un an, le critère composite décès, infarctus ou AVC est survenu chez **11,1 %** des patients sous politique prasugrel contre **11,8 %** sous politique ticagrelor (différence non significative), et les saignements majeurs ont été un peu moins fréquents avec le prasugrel (**4,2 %** contre **4,4 %**). Un essai pragmatique de grande taille qui conforte le prasugrel comme premier choix après stent.

En pratique : après stent pour syndrome coronarien aigu, le prasugrel (dose réduite à 5 mg après 75 ans ou sous 60 kg) fait au moins aussi bien que le ticagrelor sur les événements ischémiques, avec un peu moins de saignements majeurs. De quoi conforter la place de premier choix que lui donnent déjà les recommandations européennes, sans contre-indiquer le ticagrelor chez ceux qui le tolèrent bien.

[Article original](#)

Milvexian with Antiplatelet Therapy after Acute Coronary Syndrome Event.

NEJM · 29 août 2026 · 14 194 patients, essai de phase 3 contre placebo, arrêté pour futilité · ESC 2026

Le milvexian, anticoagulant oral inhibiteur du facteur XIa, ajouté au traitement antiplaquettaire dans les sept jours suivant un syndrome coronarien aigu, n'a pas réduit le critère composite décès cardiovasculaire, infarctus ou AVC ischémique : **5,4 %** contre **5,1 %** sous placebo après 12,2 mois de suivi médian. L'essai a été arrêté pour futilité après une analyse intermédiaire planifiée. Les saignements intracrâniens ou mortels n'ont pas augmenté (0,3 % dans chaque groupe), mais l'espoir d'une anticoagulation « sans saignement » efficace après infarctus s'éloigne.

En pratique : rien à changer, et une piste à ne plus attendre : ajouter un inhibiteur du facteur XIa au traitement antiplaquettaire après un infarctus ne protège pas davantage. La prévention secondaire post-SCA reste fondée sur la bithérapie antiplaquettaire adaptée au risque hémorragique, les statines à forte dose et le contrôle des facteurs de risque. Les résultats du milvexian dans la FA et l'AVC restent attendus.

[Article original](#)

Clopidogrel or Dual Antiplatelet Therapy in High-Ischemic-Risk Patients.

NEJM · 29 août 2026 · 3 203 patients, Corée du Sud, essai ouvert de non-infériorité · ESC 2026

Un an après la pose d'un stent actif chez des patients à haut risque ischémique, le clopidogrel seul s'est montré non inférieur à la bithérapie prolongée (clopidogrel + aspirine) sur le critère net à 24 mois (5,0 % contre 5,1 %). Mais ce résultat global cache deux mouvements opposés : plus de deux fois plus d'événements ischémiques sous monothérapie (3,7 % contre 1,6 %) et moins de la moitié des saignements (1,8 % contre 4,1 %). Chez le patient à haut risque ischémique, prolonger la bithérapie garde du sens.

En pratique : ne pas lire ce résultat comme une autorisation de simplifier : chez le patient à haut risque ischémique (tronc commun, bifurcation, pluritrunculaire, diabète, insuffisance rénale...) et sans risque hémorragique majeur, prolonger la bithérapie clopidogrel + aspirine au-delà d'un an réduit de plus de moitié les événements ischémiques, décès compris, au prix de saignements surtout modérés. La décision reste individuelle, à discuter avec le patient en pesant ses deux risques.

[Article original](#)

Aspirin Omission at the Time of Primary Percutaneous Coronary Intervention in STEMI.

NEJM · 29 août 2026 · 2 216 patients, Japon, essai ouvert de non-infériorité · ESC 2026

Chez des patients traités par angioplastie primaire pour infarctus avec sus-décalage de ST, le prasugrel faible dose en monothérapie débuté avant la procédure, sans aspirine, n'a pas démontré sa non-infériorité par rapport à la bithérapie de 12 mois : décès, AVC ou infarctus à un an chez 11,0 % contre 8,5 %. Les saignements majeurs ont bien diminué (5,6 % contre 8,4 %), mais au prix d'un excès d'événements ischémiques. L'aspirine garde sa place à la phase aiguë du STEMI.

En pratique : ne pas omettre l'aspirine dès la salle de cathétérisme dans le STEMI : la bithérapie reste la règle à la phase aiguë et au moins pendant les premières semaines. Les stratégies d'arrêt précoce de l'aspirine, elles, se discutent après une période initiale de bithérapie, chez le patient à risque hémorragique, et non d'emblée.

[Article original](#)

Anticoagulation Monotherapy vs Antiplatelet Monotherapy After Transcatheter Aortic Valve Implant: The ACASA-TAVI Randomized Clinical Trial.

JAMA · 30 août 2026 · Essai randomisé ouvert à évaluation en aveugle, 360 patients, Norvège · ESC 2026

Chez 360 patients de 65 à 80 ans traités par TAVI pour rétrécissement aortique serré, douze mois d'AOD anti-Xa en monothérapie ont réduit de près de moitié l'épaississement hypoatténué des feuillets au scanner à un an par rapport à l'aspirine seule, et se sont montrés non inférieurs sur le composite saignements, événements thromboemboliques et décès. Un résultat qui rouvre la question de l'anticoagulation après TAVI chez le patient sans indication d'AOD.

En pratique : chez le patient de 65 à 80 ans sans indication d'anticoagulation, un an d'apixaban ou d'edoxaban seul après TAVI divise presque par deux la thrombose infraclinique des feuillets sans excès de saignement, de thromboembolie ni de décès. Ce n'est pas encore un standard — le bénéfice porte sur un critère scanner et l'essai est de taille modeste —, mais c'est le premier essai randomisé qui rend cette stratégie défendable chez un patient jeune pour qui la durabilité de la valve compte. À discuter en réunion médico-chirurgicale, en attendant des données cliniques à plus long terme.

[Article original](#)

Atorvastatin, Cardiovascular Events, and Disability-free Survival in Older Adults.

NEJM · 29 août 2026 · Essai randomisé en double insu, 9 971 participants, Australie · ESC 2026

Chez **9 971** adultes de 70 ans ou plus vivant à domicile, sans maladie cardiovasculaire, diabète ni démence, l'atorvastatine **40 mg** a réduit de **30 %** les événements cardiovasculaires majeurs par rapport au placebo après un suivi médian de **5,9 ans** (HR 0,70 ; IC95 % 0,61–0,82). En revanche, le second critère principal — décès, démence ou incapacité physique persistante — n'a pas été modifié (HR 0,94 ; IC95 % 0,84–1,05). Premier grand essai de prévention primaire par statine dédié au sujet âgé : la statine protège le cœur, mais ne prolonge pas la vie sans dépendance.

En pratique : STAREE apporte enfin une preuve randomisée solide qu'une statine débutée après 70 ans, chez un sujet en bonne santé, réduit d'environ 30 % les infarctus, AVC, revascularisations et décès cardiovasculaires, avec une bonne tolérance globale. Proposer l'atorvastatine 40 mg à ces patients devient défendable, mais en expliquant honnêtement ce qu'elle ne fait pas : elle ne prolonge ni la vie ni l'autonomie sans démence. La décision reste partagée, en tenant compte des effets musculaires, hépatiques et glycémiques plus fréquents, et ne s'applique pas aux patients fragiles.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)**Catheter ablation for symptomatic atrial fibrillation (PVI-SHAM-AF): a randomised, double-blind, sham-controlled, multicentre trial.**

Lancet · 30 août 2026 · Essai randomisé en double aveugle contre simulacre, 262 patients, Allemagne et Pologne · ESC 2026

Premier essai en double aveugle qui compare l'ablation de fibrillation atriale à une procédure simulée (sédation et abord veineux sans cathéter) chez 262 patients symptomatiques, paroxystiques ou persistants. À six mois, la qualité de vie mesurée par le score AFEQT progresse fortement dans les deux bras, et la différence entre ablation et simulacre n'est pas significative. L'ablation réduit pourtant bien les récides de FA : le bénéfice ressenti ne tient donc pas qu'au geste lui-même.

En pratique : l'ablation garde son effet sur le rythme, mais l'amélioration spectaculaire que rapportent les patients après le geste ne lui est pas propre : une procédure simulée en obtient la plus grande partie. Au moment de proposer une ablation « pour les symptômes », il faut désormais expliquer que le soulagement attendu tient aussi à l'effet placebo et à la prise en charge globale, et réserver le geste aux patients chez qui la réduction des récides a un sens clinique. Les résultats à 12 mois sont attendus avant d'en tirer une conclusion définitive.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)**Catheter-Directed Thrombolysis in Intermediate-High-Risk Pulmonary Embolism.**

NEJM · 31 août 2026 · 558 patients, 11 centres tchèques, essai ouvert académique · ESC 2026

Chez 558 patients avec embolie pulmonaire à risque intermédiaire-élevé (hémodynamiquement stables, sPESI ≥ 1 , dysfonction ventriculaire droite et troponine ou BNP élevés), la thrombolyse dirigée par cathéter avec de faibles doses d'altéplase, en plus de l'anticoagulation, réduit de 90 % le risque de décès, de récidence ou de décompensation cardiorespiratoire à 7 jours, sans augmenter les saignements cliniquement significatifs. Premier grand essai randomisé positif de la thrombolyse par cathéter sur un critère clinique.

En pratique : c'est la preuve randomisée qui manquait : dans l'EP à risque intermédiaire-élevé bien définie (sPESI ≥ 1 , VD dilaté, biomarqueurs positifs), la thrombolyse par cathéter à faible dose d'altéplase prévient les décompensations sans excès de saignements, avec du matériel simple et peu coûteux. Cela justifie d'identifier ces patients dès l'admission et de solliciter tôt l'équipe interventionnelle plutôt que d'attendre la dégradation ; le risque d'hémorragie intracrânienne, faible mais réel, impose de respecter les contre-indications.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

124I-Evuzamitide Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosing Cardiac Amyloidosis: The REVEAL Nonrandomized Clinical Trial.

JAMA · 30 août 2026 · 170 patients suspects d'amylose cardiaque, 18 centres américains, phase 3 · ESC 2026

Chez 170 patients adressés pour suspicion d'amylose cardiaque, une TEP-TDM à l'évuzamitide marqué à l'iode 124, traceur qui se fixe sur tous les types de dépôts amyloïdes, atteint 94 % de sensibilité et 86 % de spécificité par rapport à un diagnostic de référence adjugé en aveugle. Contrairement à la scintigraphie osseuse, l'examen détecte aussi bien l'amylose AL que l'ATTR.

En pratique : rien ne change encore dans le bilan d'une suspicion d'amylose cardiaque : scintigraphie osseuse, électrophorèse, immunofixation et chaînes légères libres restent la règle. Mais un examen unique qui repère l'amylose AL sans biopsie et quantifie les dépôts dans le cœur et les autres organes se profile ; le promoteur annonce un dossier d'enregistrement. À suivre pour les cas où la scintigraphie est douteuse ou négative malgré une forte suspicion.

[Article original](#)

INSUFFISANCE CARDIAQUE

À connaître

Essai randomisé · PADN-HF-PH

Pulmonary Denervation for Heart Failure-Related Pulmonary Hypertension.

NEJM · 30 août 2026 · 264 patients, essai multicentrique chinois · ESC 2026

Chez 264 patients avec hypertension pulmonaire liée à une cardiopathie gauche et insuffisance cardiaque sous traitement optimisé, la dénervation percutanée de l'artère pulmonaire divise par deux le risque d'aggravation clinique (décès, transplantation, hospitalisation ou aggravation ambulatoire d'IC, baisse du test de marche), sans complication procédurale au-delà de quelques hématomes au point de ponction. Premier essai randomisé positif de cette technique dans l'HTP du groupe 2.

En pratique : rien à changer aujourd'hui : la technique n'est pas disponible en routine et il faudra une confirmation avec procédure simulée et des critères durs. Mais l'HTP du groupe 2, jusque-là orpheline de traitement dédié, devient une cible interventionnelle crédible : repérer à l'échographie et au cathétérisme droit les insuffisants cardiaques dont l'HTP persiste malgré un traitement optimisé prend un sens nouveau.

[Article original](#) · [Analyse ACC.org](#)

INSUFFISANCE CARDIAQUE

À connaître

Essai randomisé en grappes · TIME-HF

Effectiveness of Nurse-Coordinated, Digital-Supported Collaborative Care Model in Reducing Hospital Stay and Mortality Among Patients With Heart Failure: TIME-HF Cluster RCT India.

Circulation · 30 août 2026 · 1 507 patients, 22 centres en Inde, suivi de 2 ans · ESC 2026

Chez 1 507 patients avec insuffisance cardiaque à FEVG réduite suivis deux ans dans 22 centres indiens, un parcours de soins coordonné par des infirmiers formés et appuyé par une application mobile (stratification du risque, optimisation du traitement, éducation, suivi actif) augmente les jours vivants hors de l'hôpital et réduit la mortalité toutes causes de 22 %. Une organisation des soins qui sauve des vies là où le traitement recommandé est sous-utilisé.

En pratique : une confirmation forte de ce que les recommandations disent déjà : dans l'IC à FEVG réduite, la coordination infirmière avec titration active et suivi rapproché est un traitement en soi, avec un effet sur la mortalité que peu de médicaments égalent. Argument supplémentaire pour appuyer les protocoles de coopération et les programmes de télé-suivi, et pour ne pas laisser un patient sortir d'hospitalisation sans un rendez-vous de titration programmé.

[Article original](#)

Protocol-Based Implementation of Early Intensive Lipid Management After Acute Coronary Syndrome: The BRIDGE Trial.

JACC · 31 août 2026 · 329 patients, 10 centres, Japon, randomisation par centre · ESC 2026

Dix centres ont été tirés au sort entre un protocole d'intensification lipidique dès l'hospitalisation pour syndrome coronarien aigu (statine forte intensité, ézétimibe, anti-PCSK9 selon un algorithme, LDL reconstrôlé à 4 semaines) et la prise en charge habituelle. À six mois, **86,4 %** des patients du protocole avaient un LDL sous 70 mg/dL contre **73,7 %**, et **60,8 %** un LDL sous 55 mg/dL contre **34,5 %**. Un parcours écrit et systématique fait mieux que la bonne volonté.

En pratique : ce n'est pas une nouvelle molécule mais une organisation : un algorithme écrit appliqué avant la sortie (statine forte dose + ézétimibe d'emblée selon le LDL, anti-PCSK9 si besoin) avec un contrôle du LDL à 4 semaines et une escalade prévue d'avance fait passer bien plus de patients sous 55 mg/dL. Un tel protocole se met en place dans n'importe quel service ou cabinet, et le rendez-vous lipidique à un mois en est la pièce maîtresse.

[Article original](#)

Targeted Use of Computed Tomographic Coronary Angiography in Acute Chest Pain.

NEJM · 29 août 2026 · 3 170 patients, 14 hôpitaux du Royaume-Uni, suivi médian 3 ans · ESC 2026

Chez des patients venus aux urgences pour suspicion de syndrome coronarien aigu, chez qui l'infarctus avait été écarté mais dont la troponine ultrasensible restait au-dessus de 5 ng/L, un coroscanner ambulatoire systématique n'a pas réduit les infarctus ni les décès cardiaques par rapport à la prise en charge habituelle : **7,1 %** contre **7,3 %** après trois ans de suivi médian. Voir la coronaire ne suffit pas à changer le pronostic.

En pratique : une troponine détectable sans infarctus signale un risque, mais programmer un coroscanner à tous ces patients ne réduit ni les infarctus ni les décès cardiaques. Le coroscanner reste un examen à indication clinique (symptômes persistants, probabilité pré-test), pas un dépistage systématique de sortie des urgences. La prévention médicamenteuse, elle, ne dépend pas de l'image.

[Article original](#)

Short-Term Anticoagulant Therapy and Subclinical Leaflet Thickening in Transcatheter Aortic Valves: The NOTION-4 Trial.

Journal of the American College of Cardiology · 30 août 2026 · Essai randomisé, 347 patients analysés

Chez des patients traités par TAVI sans indication d'anticoagulation, trois mois d'AOD suivis d'un antiagrégant à vie ont divisé par plus de deux l'épaississement hypoatténué des feuillets à trois mois par rapport à l'antiagrégant seul, mais l'écart avait disparu à un an, neuf mois après l'arrêt de l'AOD. Le composite décès, AVC ou saignement majeur était plus fréquent dans le bras AOD.

En pratique : une anticoagulation de trois mois après TAVI, chez le patient sans indication d'AOD, n'apporte qu'un bénéfice transitoire sur les feuillets et s'accompagne d'un excès d'événements graves : elle n'a pas de place en routine. L'antiagrégant simple reste la référence. Lu côte à côte avec ACASA-TAVI, où douze mois d'AOD réduisent le HALT sans surrisque, cet essai suggère que si l'on anticoagule, c'est pour longtemps ou pas du tout.

[Article original](#)

Safety and efficacy of the 0/1 h pathway for myocardial infarction in the emergency department: an international, pragmatic, stepped-wedge, cluster-randomised, controlled trial.

Lancet · 29 août 2026 · Essai pragmatique en grappes, 67 624 passages aux urgences, 19 hôpitaux, 10 pays · ESC 2026

Dans **19** hôpitaux de **10** pays travaillant jusque-là avec un parcours troponine 0/3 h, le passage au parcours 0/1 h recommandé par l'ESC a été testé sur **67 624** passages aux urgences pour douleur thoracique. Le parcours 0/1 h s'est montré non inférieur pour la sécurité (décès ou infarctus de type 1 à 30 jours : **1,1 %** contre **1,2 %**), mais n'a pas raccourci d'une minute la durée de passage aux urgences, identique à **309 min** dans les deux bras. Le gain de temps attendu de la troponine rapide ne se concrétise pas sans réorganisation du reste du parcours.

En pratique : Le parcours 0/1 h de l'ESC reste sûr à grande échelle et peut être adopté sans crainte par les services qui travaillent encore en 0/3 h. Mais il ne faut pas en attendre, à lui seul, un désengorgement des urgences : le dosage rapide ne sert à rien si l'avis cardiologique, la décision de sortie et la disponibilité des lits ne suivent pas au même rythme. Pour gagner du temps, c'est tout le circuit douleur thoracique qu'il faut revoir avec les urgentistes, pas seulement l'horaire de la deuxième troponine.

[Article original](#)

LDL Cholesterol Lowering With Evolocumab Before Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction: The AMUNDSEN Randomized Clinical Trial.

JAMA · 29 août 2026 · 2 161 patients, 48 centres dans 6 pays, essai ouvert de phase 4 · ESC 2026

Injecter l'evolocumab dès la salle de cathétérisme, avant l'angioplastie d'un infarctus à haut risque, puis toutes les deux semaines pendant un an, a amené **82 %** des patients à la cible LDL (moins de 55 mg/dL et baisse d'au moins 50 %) à 12 mois, contre **40 %** avec le traitement standard. Mais décès ou hospitalisation cardiovasculaire non programmée n'ont pas différé (**14,6 %** contre **15,4 %**) : pas d'effet « pléiotrope » aigu des anti-PCSK9 au-delà du LDL.

En pratique : l'evolocumab débuté dès l'infarctus met quatre patients sur cinq à la cible LDL en un an, ce que le traitement standard ne fait que chez deux sur cinq ; mais n'en attendre aucun effet protecteur immédiat au-delà de la baisse du LDL. Le message reste celui des recommandations : intensifier vite, en associant d'emblée statine forte dose et ézétimibe, et recourir sans tarder à l'anti-PCSK9 quand la cible n'est pas atteinte, le bénéfice se jugeant sur les années.

[Article original](#)

Safety of withdrawal of pharmacological treatment after recovery from HER2 therapy-related cardiac dysfunction: the HER-SAFE trial.

Eur Heart J · 30 août 2026 · 90 patientes, essai ouvert multicentrique, suivi de 12 mois

Chez 90 survivantes d'un cancer du sein dont la dysfonction cardiaque sous anti-HER2 avait récupéré (FEVG $\geq$ 50 %, biomarqueurs normalisés, sans symptôme), l'arrêt du traitement de l'insuffisance cardiaque n'a entraîné qu'une seule récurrence modérée et asymptomatique en un an, sans événement clinique ni baisse de la FEVG à l'IRM. Premier essai randomisé sur cette question, jusque-là tranchée par habitude.

En pratique : chez une femme asymptomatique dont la FEVG et les biomarqueurs sont normalisés depuis plus d'un an après une cardiotoxicité anti-HER2, sans autre indication d'IEC ou de bêtabloquant, l'arrêt du traitement devient une option raisonnable, à discuter avec elle et à encadrer par une surveillance échographique et biologique la première année. Un petit essai qui ne clôt pas la question, mais qui lève l'interdit de la déprescription.

[Article original](#)

PRÉVENTION **À connaître** Essai randomisé · VESALIUS-CV · analyse préspecifiée

Effects of Evolocumab on Mortality Outcomes in Patients Without Previous Myocardial Infarction or Stroke: A Prespecified Analysis of the VESALIUS-CV Randomized Clinical Trial.

Circulation · 31 août 2026 · 12 257 patients, double insu contre placebo · ESC 2026

Chez 12 257 patients à haut risque sans antécédent d'infarctus ni d'AVC (athérosclérose établie ou diabète à haut risque, LDL $\geq$ 0,90 g/L), l'évolocumab a réduit de 20 % la mortalité toutes causes sur un suivi médian de 4,6 ans, avec une baisse cohérente des décès cardiovasculaires. Le modèle multi-états attribue l'essentiel de l'effet sur les décès non cardiovasculaires à la prévention des infarctus, AVC et revascularisations qui les précèdent.

En pratique : c'est la première fois qu'un hypolipémiant montre un bénéfice de survie chez des patients sans infarctus ni AVC préalable. Chez le coronarien stable, l'artéritique ou le diabétique à haut risque dont le LDL reste au-dessus de 0,90 g/L sous statine, l'argument pour intensifier avec un anti-PCSK9 ne se limite plus aux événements non fatals : il porte aussi sur la mortalité. Les événements non fatals évités pèsent sur la survie des années suivantes, d'où l'intérêt d'intensifier tôt plutôt qu'après le premier accident.

[Article original](#)

PRÉVENTION **À connaître** Essai randomisé · VICTORION-Challenge

Inclisiran vs bempedoic acid for low-density lipoprotein cholesterol lowering in high-risk patients: the VICTORION-Challenge trial.

European Heart Journal · 31 août 2026 · 402 patients, phase 4 en ouvert · ESC 2026

Premier face-à-face entre les deux hypolipémiants ajoutés le plus souvent après statine et ézétimibe : chez 402 patients en prévention secondaire dont le LDL restait $\geq$ 0,70 g/L sous statine, l'inclisiran a fait baisser le LDL de 56,3 % à 150 jours contre 15,4 % pour l'acide bempédoïque, et près de quatre patients sur cinq ont atteint leur objectif, contre un sur cinq. Tolérance comparable dans les deux bras.

En pratique : lorsque le LDL reste loin de l'objectif sous statine et ézétimibe, l'acide bempédoïque seul ne suffira presque jamais : sa baisse d'environ 15 % ne rattrape pas un écart important, là où l'inclisiran amène près de quatre patients sur cinq à la cible. L'acide bempédoïque garde sa place pour un écart modeste ou en cas d'intolérance aux statines, mais pour le patient à très haut risque qui a besoin d'une baisse de moitié, l'injection semestrielle est l'option à proposer.

[Article original](#)

PRÉVENTION **À connaître** Essai randomisé · ADHERE-ASCVD

Digital Outreach to Improve Statin Refills in Patients With Low Statin Adherence: The ADHERE-ASCVD Randomized Clinical Trial.

JAMA · 29 août 2026 · 20 604 patients, essai pragmatique en deux étapes · ESC 2026

Chez 20 604 adultes athéroscléreux ou à haut risque qui avaient cessé de renouveler leur statine, une relance numérique (message sécurisé, SMS ou e-mail) a fait passer le renouvellement à 14 jours de 12,0 à 14,4 %. Chez ceux qui n'avaient pas réagi, une seconde relance a encore gagné 2,5 points, mais changer de canal n'apportait rien par rapport à répéter le même.

En pratique : une relance simple, automatisée et répétée fait renouveler la statine un peu plus souvent, sans qu'il soit utile de multiplier les canaux. À l'échelle d'un cabinet, cela plaide pour un rappel systématique, par SMS ou messagerie, au patient dont le renouvellement est en retard, et pour un second rappel s'il ne réagit pas ; mais l'effet reste modeste, et le patient qui a cessé sa statine mérite surtout d'être interrogé sur ses raisons en consultation.

[Article original](#)

2026 HRS/PACES scientific statement on the use of antiarrhythmic drugs in understudied clinical scenarios.

Heart Rhythm · 4 septembre 2026 · Déclaration scientifique de la Heart Rhythm Society et de la Pediatric and Congenital Electrophysiology Society

Les essais sur les antiarythmiques ne couvrent pas toutes les situations rencontrées en consultation. Ce document de la Heart Rhythm Society et de la société d'électrophysiologie pédiatrique et congénitale (PACES) recense les scénarios cliniques fréquents pour lesquels il n'existe guère de repères, faute d'études, et propose pour chacun des conseils pratiques fondés sur les données disponibles et l'expérience d'un groupe diversifié de cliniciens, avec la justification de chaque recommandation.

En pratique : un document à garder sous la main pour les prescriptions d'antiarythmiques hors des sentiers battus, quand ni l'AMM ni les recommandations ne répondent. À lire en complément du compendium EHRA 2025, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'avis d'experts à adapter au patient et aux molécules disponibles.

[Article original](#)

Targeted left ventricular lead placement in biventricular pacing for heart failure: a national, multicentre, double-blind, randomised controlled trial in Denmark.

The Lancet · 31 août 2026 · Essai randomisé en double aveugle, 1 001 patients, Danemark

Chez 1 001 patients en insuffisance cardiaque avec QRS large candidats à la resynchronisation, placer la sonde ventriculaire gauche au site d'activation électrique la plus tardive n'a pas réduit, après près de quatre ans de suivi, le critère décès ou hospitalisation non programmée pour insuffisance cardiaque par rapport à la position postéro-latérale conventionnelle. Les complications de sonde étaient plus fréquentes dans le bras ciblé.

En pratique : pour une resynchronisation, chercher systématiquement la branche du sinus coronaire la plus tardivement activée n'améliore ni la survie ni les hospitalisations, et expose à davantage de complications de sonde. La position postéro-latérale non apicale reste la référence ; le temps de procédure gagne à être consacré à une sonde stable plutôt qu'à une cartographie électrique exhaustive.

[Article original](#)

Pacemaker-implantation and atrioventricular-node ablation vs pulmonary vein isolation for elderly patients with persistent atrial fibrillation: the ABLATE versus PACE trial.

European Heart Journal · 31 août 2026 · Essai randomisé ouvert, 196 patients, Allemagne et Autriche

Chez 196 patients de 75 ans et plus (âge médian 82 ans) en fibrillation atriale persistante symptomatique avec FEVG normale, la stratégie stimulateur + ablation du nœud atrioventriculaire divise par deux, à un an, le critère composite hospitalisation pour arythmie ou insuffisance cardiaque, cardioversion ou passage à la resynchronisation, par rapport à l'isolation des veines pulmonaires. Mortalité, complications et qualité de vie ne diffèrent pas.

En pratique : chez le patient de plus de 75 ans en FA persistante symptomatique à FEVG normale, la stratégie stimulateur + ablation du nœud atrioventriculaire redevient une option de première ligne face à l'isolation des veines pulmonaires : moins d'hospitalisations pour arythmie et moins de cardioversions à un an, sans surcoût de mortalité ni de complications. Le prix à payer est une dépendance définitive au stimulateur et un signal d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque qui incite à surveiller la fonction ventriculaire.

[Article original](#)

Immediate Ambulatory Electrocardiographic Monitoring in Syncope.

NEJM · 31 août 2026 · Essai randomisé ouvert, 2 234 patients, 45 hôpitaux britanniques · ESC 2026

Chez 2 234 adultes dont la syncope reste inexpliquée au terme du passage aux urgences, poser d'emblée un enregistreur ECG ambulateur de 14 jours ne réduit pas significativement le nombre de syncopes rapportées à un an par rapport à la prise en charge habituelle. Selon le communiqué du congrès, la surveillance immédiate a toutefois plus que doublé le diagnostic d'arythmie et raccourci le délai diagnostique.

En pratique : l'enregistreur de 14 jours posé dès les urgences ne fait pas baisser les récurrences de syncope, mais il repère deux fois plus d'arythmies, deux fois plus vite, et débouche sur davantage de stimulateurs. Pour le cardiologue qui reçoit un patient après une syncope inexpliquée, cela conforte l'intérêt d'un enregistrement prolongé sans attendre, plutôt qu'un holter de 24 heures programmé à distance. Le signal sur la mortalité est à confirmer avant d'en faire un argument.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)**Low-Voltage Ablation in Persistent Atrial Fibrillation: The IDEAL-AF Randomized Clinical Trial.**

JAMA · 30 août 2026 · Essai randomisé, 209 patients, 5 centres suédois · ESC 2026

Chez des patients en fibrillation atriale persistante dont la cartographie montre des zones de bas voltage étendues (au moins 3 cm²), l'ablation individualisée de ces zones en complément de l'isolation des veines pulmonaires fait presque doubler la proportion de patients sans arythmie et sans antiarythmique à un an, avec une meilleure qualité de vie et sans surcroît d'événements graves.

En pratique : après plusieurs essais négatifs sur l'ablation de substrat, IDEAL-AF montre qu'une approche ciblée sur des zones de bas voltage réellement étendues améliore nettement le résultat dans la FA persistante. Pour le cardiologue qui adresse, cela plaide pour orienter les FA persistantes, surtout chez le sujet âgé au substrat probable, vers des centres qui cartographient le voltage et savent traiter ces zones. La stratégie ne concerne pas les patients sans bas voltage significatif.

[Article original](#) · [Analyse ACC.org](#)**Antithrombotic therapy after percutaneous coronary intervention in patients with atrial fibrillation: an individual patient data network meta-analysis.**

European Heart Journal · 30 août 2026 · Méta-analyse en réseau sur données individuelles, 6 essais randomisés, 10 634 patients

Sur les données individuelles de 10 634 patients en fibrillation atriale traités par angioplastie, le choix entre AOD et AVK ne modifie pas le risque de décès cardiovasculaire, d'infarctus ou d'AVC à un an, mais l'AOD associé à un seul inhibiteur P2Y12 divise par deux les saignements majeurs TIMI par rapport à l'AVK en trithérapie. En revanche, se passer du second antiagrégant expose à plus d'infarctus et de thromboses de stent dans les 14 premiers jours.

En pratique : après angioplastie chez un patient en fibrillation atriale, l'AOD reste préférable à l'AVK quelle que soit la stratégie antiagrégante, d'abord pour le risque hémorragique — y compris intracrânien. Le passage rapide à la bithérapie AOD + clopidogrel est confirmé comme la stratégie la plus sûre, mais le surrisque de thrombose de stent dans les deux premières semaines plaide pour garder l'aspirine quelques jours à quelques semaines chez le patient à fort risque thrombotique et faible risque hémorragique.

[Article original](#)

Increasing plasma potassium and risk of atrial fibrillation: the POTCAST trial.

European Heart Journal · 30 août 2026 · Analyse prédéfinie de l'essai randomisé POTCAST, 1 200 porteurs de DAI ou CRT-D

Analyse prédéfinie de l'essai POTCAST chez 1 200 porteurs de défibrillateur (DAI ou CRT-D) avec une kaliémie inférieure ou égale à 4,3 mmol/L : une stratégie visant le haut de la normale (conseils alimentaires, antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, supplémentation potassique) réduit d'un tiers les événements cliniques liés à la fibrillation atriale sur 3,3 ans de suivi médian, que le patient ait ou non un antécédent de FA.

En pratique : chez un porteur de DAI ou de CRT-D dont la kaliémie stagne à 4,3 mmol/L ou moins, viser 4,5 à 5,0 mmol/L par un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, un apport potassique et le régime est une mesure simple et peu coûteuse qui semble réduire à la fois les arythmies ventriculaires et les événements liés à la fibrillation atriale. Cela suppose un contrôle régulier de la kaliémie et de la fonction rénale. En dehors des porteurs de défibrillateur, le bénéfice reste à démontrer.

[Article original](#)

Dual antithrombotic therapy using potent antiplatelet inhibitors in atrial fibrillation and acute coronary syndrome: a randomized controlled trial.

Nature Medicine · 29 août 2026 · Essai randomisé ouvert, 602 patients, Allemagne et Autriche, arrêté prématurément

Chez le patient en fibrillation atriale hospitalisé pour syndrome coronarien aigu, un mois de bithérapie AOD + ticagrelor ou prasugrel a été comparé à AOD + clopidogrel avec aspirine pendant l'hospitalisation. L'essai a été interrompu après 602 des 1 474 patients prévus, sur alerte du comité de sécurité : les inhibiteurs P2Y12 puissants ont fait saigner davantage sans réduire clairement les événements ischémiques.

En pratique : chez le patient en fibrillation atriale anticoagulé par AOD après un syndrome coronarien aigu, le clopidogrel reste l'inhibiteur P2Y12 de la bithérapie. Remplacer le clopidogrel par du ticagrelor ou du prasugrel, même pour un seul mois, fait saigner davantage sans gain ischémique démontré, et un saignement même modéré double le risque d'événement ischémique ultérieur. Cet essai conforte la position des recommandations actuelles.

[Article original](#)

Pulmonary Vein Isolation Using Pulsed Field Ablation With vs Without Posterior Wall Isolation in Patients With Symptomatic Persistent Atrial Fibrillation: The PIFPAF-PFA Randomized Clinical Trial.

JAMA · 29 août 2026 · Essai randomisé, 206 patients, 6 centres suisses, moniteur implantable chez tous · ESC 2026

Chez 206 patients en fibrillation atriale persistante symptomatique ablatés par champ pulsé, ajouter l'isolation de la paroi postérieure de l'oreillette gauche à l'isolation des veines pulmonaires ne réduit pas significativement la récurrence de tachyarythmie atriale détectée par moniteur implantable entre le 3^e et le 12^e mois. La charge en arythmie et les récurrences longues sont en revanche plus faibles, signaux à confirmer dans un essai plus grand.

En pratique : même avec le champ pulsé, l'isolation systématique de la paroi postérieure n'a pas fait la preuve qu'elle réduit les récurrences de FA persistante : l'isolation des veines pulmonaires reste le geste de référence, et l'extension à la paroi postérieure relève du cas par cas. Le signal sur la charge en arythmie et sur les épisodes de plus d'un jour mérite un essai de plus grande taille avant de changer la stratégie.

[Article original](#)

Oral Relaxin Receptor Agonist AZD5462 in Participants With Chronic Heart Failure: Primary Results From the LUMINARA Trial.

Circulation · 30 août 2026 · 375 patients, double aveugle contre placebo, 57 sites dans 10 pays · ESC 2026

Premier essai de phase 2b d'un agoniste oral du récepteur de la relaxine (AZD5462, une prise par jour) chez 375 insuffisants cardiaques déjà bien traités, répartis en deux cohortes selon la FEVG ($\leq 35\%$ ou $41\text{--}55\%$). Le médicament est bien toléré ; il réduit les résistances vasculaires systémiques à FEVG intermédiaire et préservée, mais l'effet sur le volume téléstolique à FEVG réduite manque de peu la signification. Un signal hémodynamique, pas encore un traitement.

En pratique : rien à prescrire, mais un nom à retenir : l'AZD5462 est le premier agoniste oral de la relaxine à montrer un effet hémodynamique crédible dans l'IC chronique, y compris à FEVG préservée. Les auteurs appellent à des essais plus larges et plus longs sur les événements cliniques ; ce sont eux qui diront si la voie de la relaxine tient ses promesses.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

Lipoprotein(a) and Atherosclerotic Cardiovascular Disease Among Adults Aged 20 to 100 Years.

Circulation · 30 août 2026 · 103 341 adultes, cohorte prospective, suivi médian 12,5 ans

Dans une cohorte de population de 57 899 femmes et 45 442 hommes de 20 à 100 ans, dont 18 % âgés de 70 ans et plus, l'augmentation relative du risque athéroscléreux par tranche de 50 mg/dL de Lp(a) est la même à tout âge et dans les deux sexes (HR de 1,12 à 1,18). Comme le risque de base grimpe avec l'âge, l'excès absolu d'événements lié à une Lp(a) élevée est le plus fort après 70 ans.

En pratique : l'âge avancé n'efface pas la Lp(a) : un octogénaire avec une Lp(a) très élevée cumule le risque relatif de son taux et un risque de base déjà important, d'où le plus grand nombre d'événements attribuables. En attendant les essais de traitements spécifiques, le dosage unique de la Lp(a) recommandé au moins une fois dans la vie garde son sens chez le sujet âgé, pour affiner le niveau de risque et justifier un contrôle plus strict du LDL et des autres facteurs.

[Article original](#)

Half-dose rivaroxaban vs antiplatelet therapy for preventing silent cerebral embolism after left atrial appendage occlusion: the HALO-SCE trial.

European Heart Journal · 31 août 2026 · Essai randomisé multicentrique, 164 patients, Chine

Chez 164 patients dont la fermeture d'auricule gauche était réussie à 45 jours, le rivaroxaban 10 mg par jour, comparé à un traitement antiagrégant, a réduit de moitié et plus les nouvelles embolies cérébrales silencieuses détectées par IRM de diffusion sur un an, avec de meilleurs scores cognitifs à 12 mois. Les événements cliniques, rares, étaient numériquement moins fréquents sous rivaroxaban.

En pratique : ce petit essai n'autorise pas à prescrire un AOD demi-dose au long cours après fermeture d'auricule, mais il rappelle qu'un tiers des patients sous antiagrégant seul développent des micro-embolies cérébrales dans l'année. Chez un patient éligible à l'anticoagulation après une fermeture réussie, l'hypothèse d'une anticoagulation réduite mérite d'être suivie dans les essais à venir sur critères cliniques.

[Article original](#)